外科学肝胆胰脾疾病

考频（7-11题，★★★）：A_1 0-3　A_2 2-7　B 0-4　X　1-3

①细菌性肝脓肿

②~~肝癌~~

③门脉高压症

④胆系疾病：胆囊结石、胆囊炎、胆囊癌、胆管结石、胆管炎、胆管癌、其它胆系疾病

⑤~~胰腺炎~~

⑥胰腺肿瘤：胰腺癌、胰腺内分泌肿瘤

核心精讲

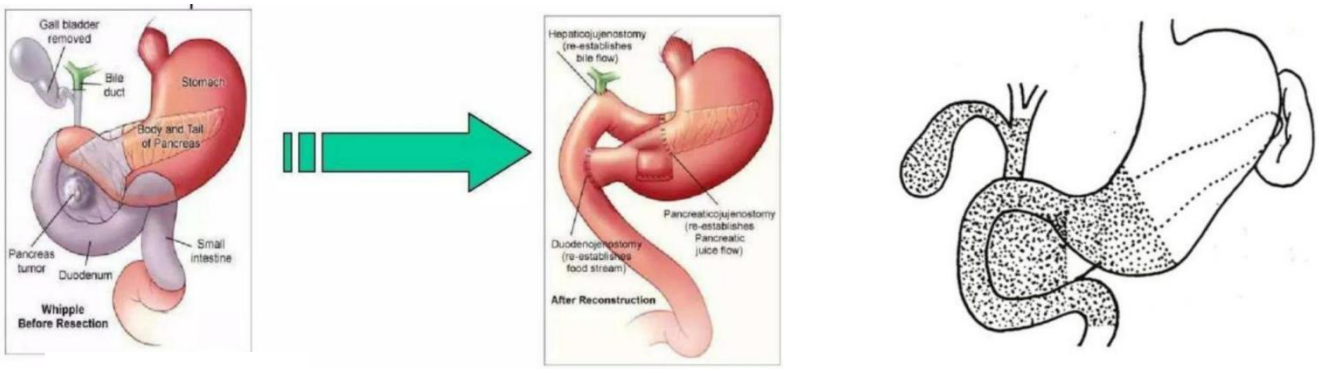
细菌性肝脓肿

性感认识：小而多

一、感染途径

外科　细菌性肝脓肿&门脉高压症
00:01:21--00:06:37

胆道梗阻（最主要）	胆道结石、蛔虫、肿瘤、胆肠吻合口狭窄如Whipple手术 大肠杆菌、厌氧菌、克雷伯杆菌多见
肝动脉	心内膜炎、皮肤化脓、骨髓炎，金葡菌多见
门静脉	阑尾炎、痔感染、菌痢，大肠杆菌多见
淋巴系统	
直接感染	开放性肝损伤尤其中央型



「理顺知识点」

- Whipple 手术/胰十二指肠切除术：一种治疗胰头癌的手术方式，可导致胆肠吻合口狭窄
  - 切除范围：胰头、十二指肠、远端胃、空肠近段、胆囊、胆总管
- XX道（消化道、泌尿道、胆道等）一般 G^- 杆菌（大肠杆菌）和厌氧菌多见；近年来以来克雷伯杆菌在胆道梗阻中也成为非常常见的致病菌

二、临床表现

外科　细菌性肝脓肿&门脉高压症
00:06:37--00:09:12

1.急性起病、寒战高热、肝区疼痛（持续钝痛或胀痛）、肝肿大、可有黄疸，血WBC↑

（VS 原发性肝癌：肝区疼痛、肝肿大或触及不规则质硬结节、可有黄疸，肝炎肝硬化等病史）

2.并发症

①右叶脓肿穿破→膈下脓肿、脓胸、支气管胸膜瘘、支气管胆瘘

②左叶脓肿穿破→化脓性心包炎、心脏压塞

③向腹腔穿破→腹膜炎

④穿破门静脉和胆管壁→大量出血、上消化道出血

⑤脓毒症、感染性休克

三、检查

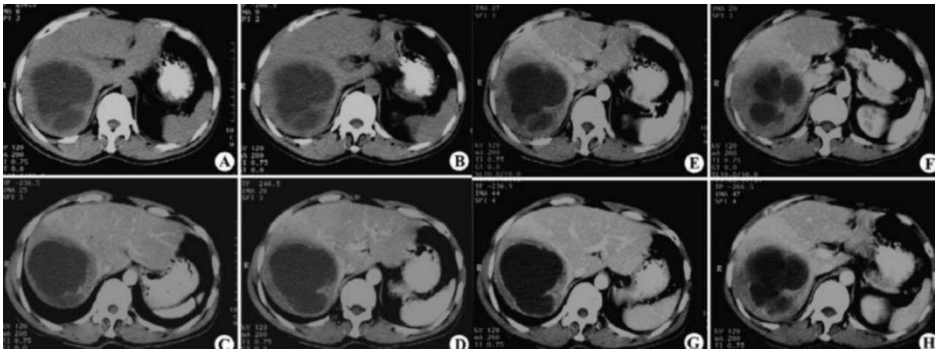
外科　细菌性肝脓肿&门脉高压症
00:09:12--00:13:32

①B超（首选）：液性暗区，常为多个「小耳朵」

②CT：囊性低密度灶、增强后明显边缘强化（脓肿壁为肉芽组织），常为多个

③肝穿刺（金标准）

《诊断学》：禁止肝穿刺：肝包虫病、肝血管瘤等



「理顺知识点」

- 细菌性肝脓肿，细菌可以入血，但是不做血培养而要做肝穿刺，因为肝脓肿是在肝脏内一个封闭的脓腔，细菌是间歇性入血的，不是持续入血，因此血培养阳性率不高，确诊一定靠肝穿刺在脓液里找到细菌
- 感染性心内膜炎赘生物长到瓣膜上，持续暴露在血循环中,因此有持续性的菌血症，血培养是感染性心内膜炎的首选和金标准，结合银标准超声心动图即可做出诊断

四、治疗

外科　细菌性肝脓肿&门脉高压症
00:13:32--00:16:44

①三代头孢+甲硝唑：首选；且是小而多的细菌性肝脓肿最佳方法（小耳朵）

②单发较大脓肿（3-5cm）还需穿刺/置管引流

「理顺知识点」

- 外科脓肿（感染）处理原则
  - 抗生素作为首选
  - 单独抗生素无效时→抗生素+穿刺/置管引流
  - 仍无效→抗生素+手术切开引流
    - 手术切开引流主要针对脓肿比较大/分隔比较多、慢性肝脓肿、脓肿破裂、胆源性肝脓肿
    - 在临床上对慢性肝脓肿时，也可考虑肝脏的部分切除

五、鉴别

外科　细菌性肝脓肿&门脉高压症
00:16:44--00:20:45

细菌性肝脓肿	阿米巴肝脓肿
化脓性炎	变质性炎
起病急、寒战高热	起病缓、少有高热
血WBC↑、以中性粒细胞为主	血WBC可↑、以嗜酸性粒细胞为主
黄白色脓液、可有臭味，脓液找到细菌确诊	棕褐色脓液、无臭味，脓液找到滋养体确诊
脓肿常较小、多发	脓肿常较大、单发（右叶多见）

专题串联

肝解剖

①Glisson鞘：肝内胆管、肝动脉、门静脉（注意：没有肝静脉）

②Couinaud分段依据：肝静脉、门静脉（格格没有的、我察贵人有、我有2个静脉）

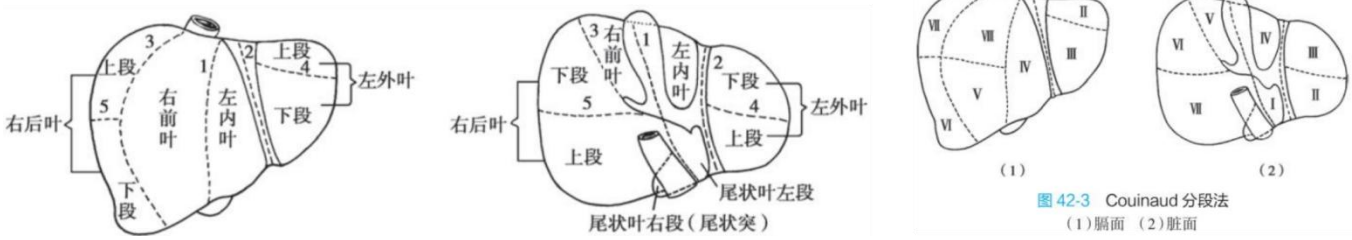


图 42-3　Couinaud 分段法
（1）膈面　（2）脏面

「理顺知识点」

- 原发性肝细胞癌：治疗首选根治性手术切除肝段或肝叶（解剖性肝切除术），有时可做右半肝切除术，因为这里切除的依据是肝中静脉，左右肝大小相同，切除右叶不会引起肝衰竭

真题解析·细菌性肝脓肿

外科　细菌性肝脓肿&门脉高压症
00:24:55--00:34:32

1.2013N114-115A男性，70岁。1年前因壶腹癌行Whipple手术，手术恢复好。近2月来反复发热，伴寒战，最高体温达39.5℃,WBC15 × 10^9/L，血清ALT121U/L，TBil58μmol/L，CT示肝内多发直径1-2cm低密度灶，边缘强化明显。

114.以下拟诊中可能性最大的是

A.肝转移癌

B.急性胆管炎

C.急性肝炎

D.多发性肝脓肿

115.发生上述情况的原因是

A.肿瘤复发转移

B.胆肠吻合口狭窄

C.手术时输血感染

D.免疫功能低下

　答案：1 DB

2.2024N100−102A女性，64岁。持续右上腹痛伴寒战、高热3天入院。既往有冠心病3年，糖尿病2年。查体：T39.6度，巩膜无黄染，右肋缘下深压痛，无肌紧张，肝区叩痛阳性。化验：血WBC15.8×10^9/L。B超：肝稍大，胆囊7cm×4cm，壁厚0.4cm，呈淤胆状，肝右叶可见8cm×6cm低回声区。

100.最可能的诊断是

A.急性胆囊炎

B.急性胆管炎

C.肝癌

D.肝脓肿

101.为明确诊断，首选的检查是

A.腹部CT

B.腹平片

C.ERCP

D.肝脏穿刺

102.此病的最大危害是

A.转移扩散

B.脓毒症

C.破裂出血

D.肝功受损

　答案：2 DAB